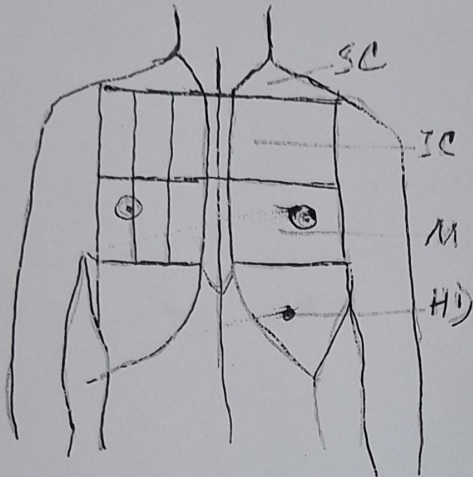


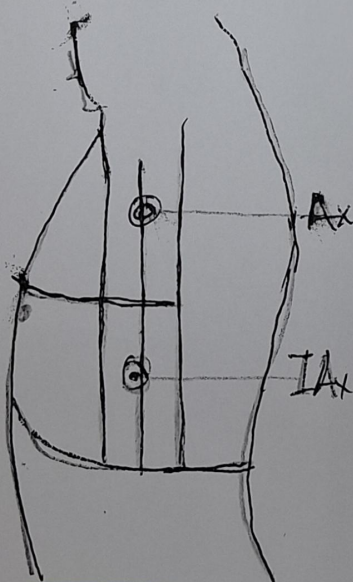
TOPOGRAFIA TORAXICA

R

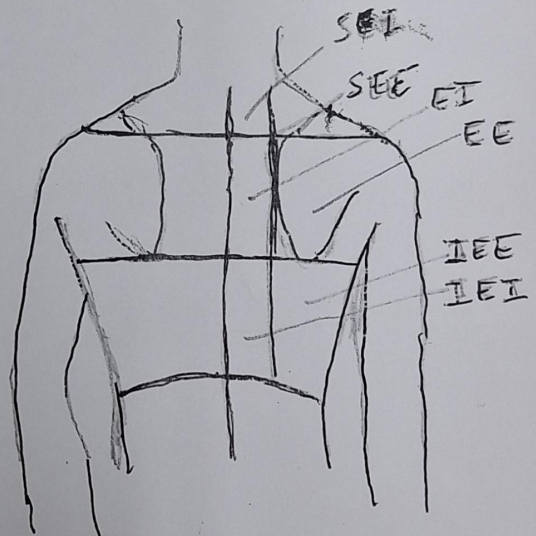
1



CARA ANTERIOR



CARA LATERAL



CARA POSTERIOR

1. Generalidades. Topografía Torácica. Reparos Anatómicos.

2. Inspección: a-General: Estado de nutrición. Cianosis. Aleteo Nasal. Tiraje alto y/o bajo. Utilización de músculos respiratorios. Accesorios. Respiración en Balancín. Tórax Inestable. Facies. Decúbito.

b-Especial: Examen cuidadoso de Piel, Celular subcutáneo del Tórax. Músculos. Arañas Vasculares. Vesículas o Costras. Cicatrices. Fistulas. Atrofias musculares. Circulación Venosa colateral. Edema. Ginecomastia uni o bilateral.

c-Torax Estático: para detectar Deformidades congénitas o Adquiridas, ^③Bilaterales: como el Tórax en Tone, Paralítico, Cifoescoliótico en Quilla, en Embudo y ^④Unilaterales que se expresan por Abovedamiento o Retracciones.

d-Tórax Dinámico: se examina los movimientos respiratorios, recogiendo sus características semiológicas. Acrónimo: FRATT: Frecuencia Ritmo, Amplitud, Tipo y Tiempo.

OJO: Interpretando correctamente los hallazgos del examen de los movimientos Respiratorios (Tórax Dinámico) es posible presuponer el tipo de Trastorno Ventilatorio subyacente.

Las Enfermedades Respiratorias se pueden expresar por RESTRICCION de la Expansión toracopulmonar (afecciones Restrictivas) como ser Condensaciones, Atelectasia, Intersticiopatías, Derrames pleurales y Neumotórax, o expresarse por OBSTRUCCION del flujo de aire por las Vías Aéreas (afecciones Obstructivas) como el Asma Bronquial, la Bronquitis Crónica, los Cuerpos Extraños en vía aérea.

• El Patrón Respiratorio o Ventilatorio RESTRICTIVO se caracteriza por Taquipnea con Hipopnea.

• El Patrón Respiratorio OBSTRUCTIVO: si es ^①Intratorácico se caracteriza por Bradipnea, Prolongación del tiempo espiratorio y Tiraje. Si es ^②Extratorácico se manifiesta por Dificultad Inspiratoria con Tiraje alto y/o bajo y también Cornaje y Estridor Laríngeo.

3. Palpación:

a-General: para reconocer: alteraciones de la sensibilidad cutánea.
Enfisema Subcutáneo. Frémito Pleural. Frémito Brónquico.
Adenopatías: supraclaviculares, axilares. Edema. Examen de las Mamas.

b-Elasticidad Torácica: comprobar la disminución de la misma.

c-Expansión Torácica: Alteraciones de la expansión bilateral, unilateral o Localizada.

d-Vibraciones Vocales: solicitar al pte pronunciar la palabra 33 y recorrer la superficie del tórax con la palma de la mano para su reconocimiento, normal, o aumentada o disminuida y abolida.

Aumento de las VV se requiere: Condensación del tejido pulmonar.

Permeabilidad Bronquial.

Contacto con Pared del Tórax.

Ejemplo: Neumonías y Cavidades Volu-
monosas.

Disminución de las VV: Cuando hay dificultad en la transmisión por
Atelectasia. Enfisema. Paquipleuritis. Derrame Pleural. Neumotórax. Obesidad marcada.

Abolición de las VV: igual a la anterior pero mas acentuadas las patologías.

4. Percusión

La percusión permite la audición de las características de los sonidos generados en la superficie corporal. Con el golpe vibran los tejidos y emiten ondas sonoras, transportadas por el aire y así llegan al oído produciendo la sensación de sonido.

Semiotecnia: es la dígito-digital. Un dedo, el índice derecho es el percutor y golpea sobre otro dedo, el medio izquierdo denominado plexímetro. Este se apoya sobre el espacio intercostal en dirección horizontal y perpendicular a él el percutor golpea por detrás de la uña. El golpe debe ser suave y breve. Debe percutir se cara anterior, vertice, posterior y laterales de arriba a bajo.

Características de los sonidos obtenidos por percusión:

Existen tres sonidos fundamentales

- Sonoridad : se denomina así al sonido obtenido al percutir el pulmón aireado. En su forma más pura se obtiene en la región infraclavicular. Su intensidad es fuerte, su tono es bajo y su duración prolongada.
- Matidez: es el sonido obtenido al percutir sobre un pulmón no aireado como ocurre en las neumonías y atelectasia o cuando se interpone líquido entre la superficie pulmonar y la pared torácica como en los derrames pleurales. Su intensidad es escasa, tono alto y duración breve.
- Timpanismo : se obtiene al percutir el espacio de traube. Es un sonido musical de intensidad muy fuerte, tono intermedio entre los dos anteriores y duración muy prolongada.

También existen dos sonidos muy importantes

- Submatidez : variación de la matidez, se caracteriza por tener mayor sonoridad y tono grave. Se encuentra en zonas del pulmón con menor aireación que lo normal o cuando entre una viscera maciza y la pared del torax hay una lamina delgada de pulmón.
- Hipersonoridad : variedad de la sonoridad caracterizada por ser más intensa, mas grave y duración mayor. Se obtiene en pulmones hiperaireados como enfisema y asmáticos o en el Neumotórax.

HALLAZGOS ANORMALES EN LA PERCUSIÓN

- Matidez o Submatidez: Evocan : Condensaciones pulmonares (Neumonía, Atelectasia o grandes Tumores) y Derrame Pleural.
- Hipersonoridad o Timpanismo: Evocan: Localizadas: Bullas enfisematosas o Cavernas pulmonares superficiales de pared fina. También el Neumotórax (mas Generalizado). Y siempre generalizado: Enfisema y asma.

5. Auscultación

Se realiza con el estetoscopio biauricular respirando el paciente en forma lenta y profunda con la boca abierta. La membrana debe ser apoyada firmemente sobre el tórax desnudo. Debe auscultarse siguiendo el mismo orden que la percusión y comparar áreas simétricas.

Hallazgos normales a la auscultación pulmonar

- ✗ Soplo laringotraqueal o respiración bronquica: es producido por turbulencias generadas por el aire a su paso por las vías aéreas alta. Es soplante, tono alto y audible en inspiración y espiración con una pausa entre ambos. Se ausculta sobre la traquea en la cara anterior y en el dorso sobre la columna vertebral alta. NO SE AUSCULTA SOBRE LAS PLAYAS PULMONARES.
- ✗ Murmullo Vesicular: se ausculta sobre todo el pulmon normal en contacto con el tórax. Es resultado del paso del aire inspirado por los alveolos pulmonares que se distienden. Es suave de tono bajo y se ausculta predominantemente en la inspiración. Las regiones mejor auscultable son los dos primeros espacios intercostales, ~~ax~~ la región axilar y en las infraescapulares.
- ✗ Respiración Broncovesicular: es la superposición de los anteriores en ciertos sectores del torax, como ser la bifurcación de la traquea y sobre los grandes bronquios. Tiene una fase espiratoria mas intensa y larga que el mv.

HALLAZGOS ANORMALES A LA AUSCULTACION PULMONAR:

Hay tres categorías:

	1. <u>Alteraciones cuantitativas del Murmullo vesic</u>
	2. <u>Reemplazo del Murmullo vesicular.</u>
	3. <u>Ruidos Agregados.</u>

- 1- Alteraciones Cuantitativas : Aumento y Disminución o abolición
- 2- Reemplazo : Soplo Tubario. Soplo Pleural. Soplo Cavernoso y Anfórico.
- 3- Ruidos Agregados:

1. <u>Sibilancias y Roncus.</u>
2. <u>Estertores o Rales.</u>
3. <u>Frote Pleural.</u>

Auscultación de la Voz

Normal y Cuchicheada.

- Alteraciones:

Broncofonia
Pectorillogia
Pectorillogia Afona
- Disminución o Abolición de la voz.

1. Síndromes de Vías Aereas

- a. Síndromes Obstructivos ✓
- b. Síndromes Infecciosos ✓
- c. Bronquiectasias ✓

Características Clínicas de los Sx. Obstructivos

Disnea. Tos. Tiraje alto y bajo.
 Tórax en inspiración permanente.
 Elasticidad torácica Disminuida
 vibraciones Vocales Disminuidas
 Descenso del diafragma hasta D12 por percusión.
 Sibilancias y Roncus. Cornaje.
 Cuadro asfíctico, imposibilidad de hablar y **Estridor** Laringe.
 Cuadros clínicos de Asma Bronquial y EPOC: bronquitis crónica y enfisema pulmonar.

*Inspiración**Tiraje alto y bajo**Broncofonia**Tiraje alto y bajo**Expiración**Disnea Inspiratoria**Disnea Expiratoria**Tiraje*2. Síndromes Infecciosos:

- . Traqueobronquitis agudas
- . Reactivación aguda en bronquitis crónica.

Bronquiectasias: Tos, expectoración copiosa, vómica. Hemoptisis.

2. Síndromes Parenquimatosos

- a. Síndrome de Condensación.
- b. Síndrome de Atelectasia.
- c. Síndrome Intersticial.
- d. Síndrome Cavitario.

Características de la Condensación

NEUMONIAS

VV aumentada. Matidez a la P.
 MV abolido. Soplo Tubario. Broncoforia, Pectoriloquia y P. áfona.
 Rales crepitantes de inicio y final

Características de la Atelectasia:

ATELECTASIA OBSTRUCTIVA

VV abolida. Matidez a la P.
 MV abolido (silencio auscultatorio)

Característica del Síndrome Intersticial

Examen: rales tipo Velcro.

Características del Síndrome Cavitario

Cavidad mayor de 3 cm/d. superficial, de contenido aéreo, paredes lisas y con bronquio libre. Soplo cavernoso. Hoy se descubre con Rx. Tbc. Hongos. Neo. Absceso.

3. Síndromes Pleurales

① Neumotórax : Presencia de aire en cavidad pleural.
Proviene de solución de continuidad pleural visceral espontáneo "ruptura de bulla congénita" o secundaria a Enfisema pulmonar, EPOC, Absceso, Cavernas Tbc, Neoplasia pulmonar. Traumatismo a torax abierto o cerrado. Iatrogénico. Hay colapso pulmonar dependiendo del volumen del neumotórax.

Características: Dolor de tórax. Disnea. El examen: VV abolidas. Hipersonoridad a la percusión. MV ausente. Soplo Anfórico. El Neumotórax hipertensivo produce shock por interferir el retorno venoso y disminución del gasto cardíaco.

② Derrame Pleural : Acumulación anormal de líquido . Se dividen en dos tipos segun fisiopatología: Trasudados y Exudados.
Los trasudados son por insuficiencia cardíaca pericarditis constrictivas y Obstrucción de vena Cava superior en todos hay aumento de la presión hidrostática. También dá trasudados el síndrome nefrótico y la cirrosis hepática por disminución de la presión oncótica.
Exudados por Infecciones, Neoplasias, Tromboembolismo pulmonar, Colagenopatias, Hemotorax, Quilotorax, Enfermedades abdominales como pancreatitis y abscesos subfrénicos.

Características del Derrame Pleural: Disnea. Tos seca. Dolor intenso. VV abolido. Mate Percusión. MV abolido. Sobre la matidez: soplo pleurítico.

4. Síndromes vasculares.

- Hipertensión Pulmonar: recordar que la Pa pulmonar normal es de 25 mmHg. Su aumento puede ser Agudo o Crónico. La aguda se presenta en los casos de Tromboembolismo Pulmonar y la crónica debido a enfermedad pulmonar como el EPOC, afecciones intersticiales y otras afecciones neuromusculares, se denominan Cor-pulmonale, llevan a la Insuficiencia Cardíaca derecha.
- * El Cor-Pulmonale produce disnea, fatiga y síncope. Da ingurgitación yugular, hepatomegalia, pulso hepático, reflujo hepatoyugular, Signo de Dreessler, P2 aumentado, S5 en foco pulmonar y tricuspídeo por insuficiencia valvular. Galope derecho. Cor-pulmonale descompensado.
- * El Tromboembolismo pulmonar es agudo y los síntomas pueden ser mínimos (disnea pasajera) o mortal (muerte súbita) en relación con el tamaño del embolo. El cuadro mas comun da disnea, taquipnea, dolor toracico, sudoración profusa, tos, angor, síncope. Es muy clásico su presentación en pacientes con factores de riesgo: posoperatorios y largos periodos de reposo en cama.

5. Síndrome Mediastinal.

- Recordar la división topográfica: Mediastino anterior, medio y posterior. Importante por que cada compartimiento tiene estructuras anatómicas particulares.
- Los síntomas pueden ser molestia o dolor retroesternal, o tos, disfagia por compresión de traquea y esófago.
- Síndrome de la Vena Cava Superior: congestión venosa por distensión yugular, cara y cuello con edema, abotagamiento facial, cefalea.
- Síndrome de Claude-Bernard-Horner por compromiso del Simpático dando miosis, enoftalmía, disminución de la hendidura palpebral y sequedad de la piel de hemicara homolateral.
- Recordar síntomas sistémicos como debilidad muscular por Miasina vinculada con Timomas.